Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 07

Neoplasias Digestivas e Ostomias

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Neoplasias digestivas e ostomias

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Suspeite pelo sintoma, confirme com biópsia, estadie (TC; ecoendoscopia no esôfago e no estômago; RM no reto), trate pelo estádio e, se houver estomia, demarque antes e proteja a pele.

1. **Esôfago:** escamoso = tabaco e álcool, terço médio; adeno = Barrett e obesidade, distal.
2. Esôfago localmente avançado, M0: neoadjuvância + esofagectomia; escamoso cervical = QRT definitiva.
3. **Estômago:** *H. pylori*; Lauren intestinal × difuso (anel de sinete, linite).
4. **Gastrectomia:** margem 3 cm (expansivo) ou 5 cm (infiltrativo); D2 se cT2+ ou N+.
5. **SUS 2026:** FIT de 50 a 75 anos em assintomáticos; positivo → colonoscopia.
6. **Direito:** anemia e massa. **Esquerdo:** obstrução. **Reto:** tenesmo.
7. Reto médio/baixo T3–T4 ou N+: RM, neoadjuvância e excisão total do mesorreto.
8. **Reto médio ou baixo obstruído:** derivar, não ressecar na urgência.

Estomias

Tipo	Lado · efluente
Colostomia	Esquerda · pastoso a sólido
Ileostomia	Direita · líquido, protrusa
Urostomia	Direita · urina

Pegadinha

Estoma normal é vermelho e úmido; escuro exige avaliação urgente. Recorte largo da placa causa dermatite. Pó trata pele úmida; pasta veda desnível.

Checklist antes da prova

- ☐ Diferencio escamoso de adenocarcinoma
- ☐ Sei Lauren, Borrmann e os epônimos
- ☐ Sei margem e D2 do gástrico
- ☐ Sei o rastreamento colorretal no SUS
- ☐ Separo cólon e reto no tratamento
- ☐ Sei a conduta na obstrução
- ☐ Sei demarcar e trocar a bolsa